

Кой основен патологичен процес се наблюдава в костите, изграждащи колянната става:



1. Остеопороза

2. Остеосклероза

3. Остеолиза

4. Остеодистрофия

5. Периостална реакция.

Гонарт-
роза

износ
на

стабна

тръжен

стеснение на ставата

Рентгеновата картина е:



Rö

1. Нормална

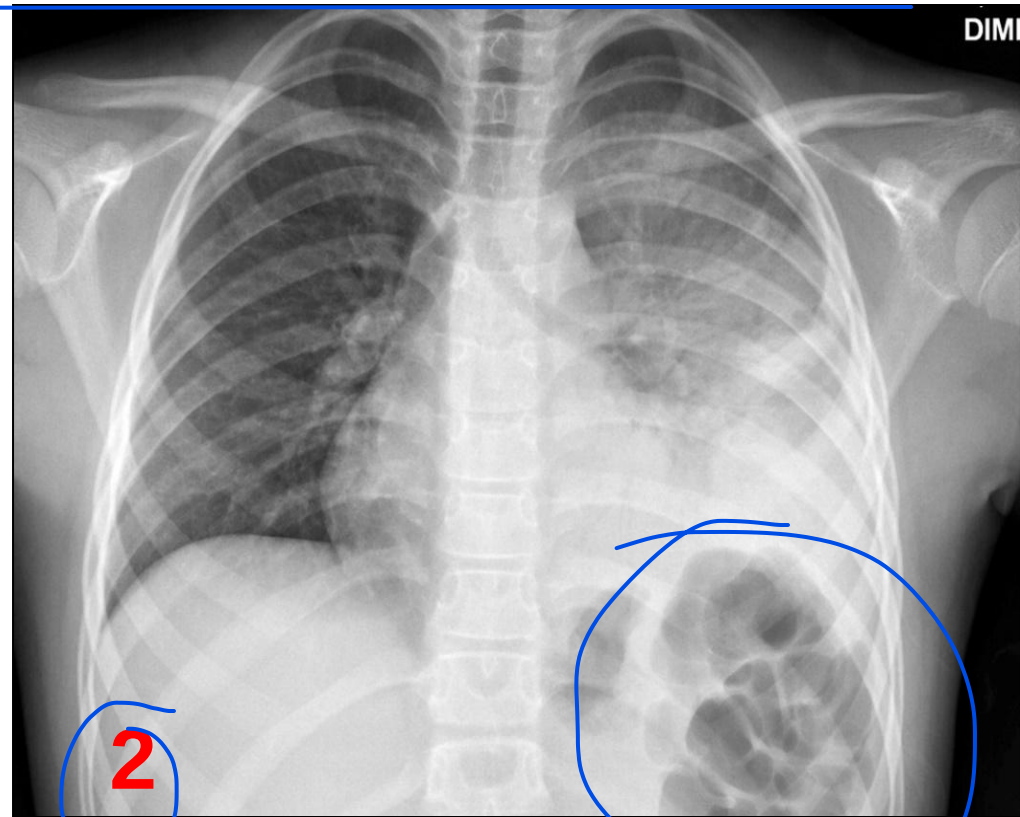
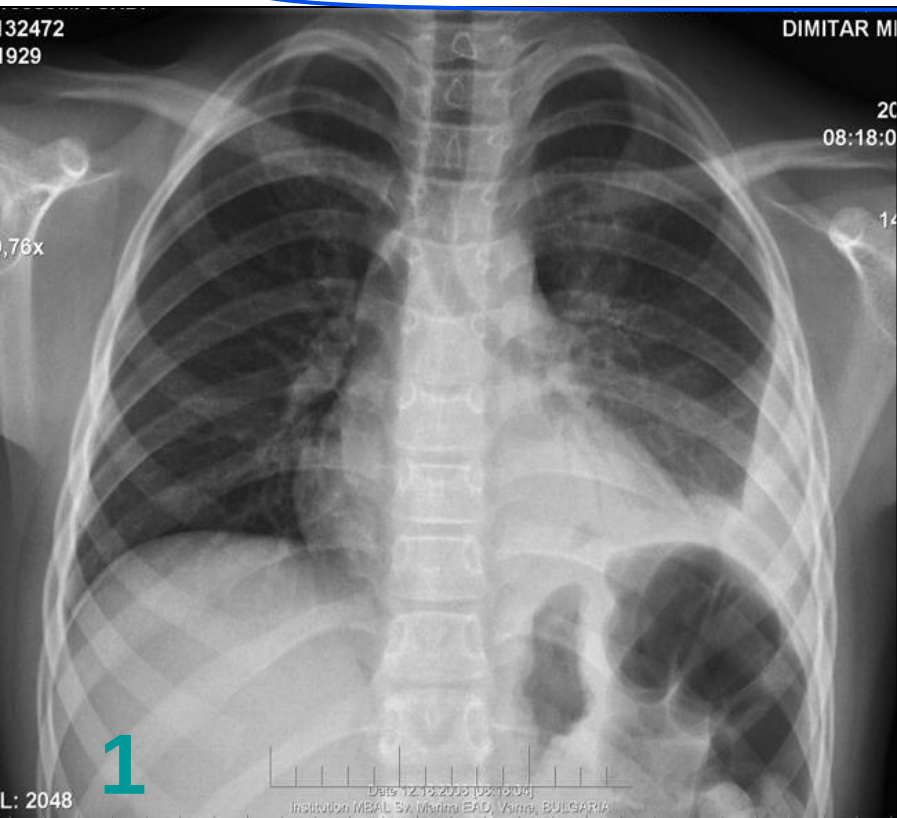
2. Абнормна

Няма газове ☹️

Нормална стеноза

~~Херитис?~~

Посочете коя от двете рентгенографи е
диагностичната и коя е на усложнението.



Рi

Усложнение

Възможна пневмония

Патологичните находки на обзорната рентгенография на корема са:

Rö.

В коридора на

1. Калцификати

2. Хидроаерични
колекции

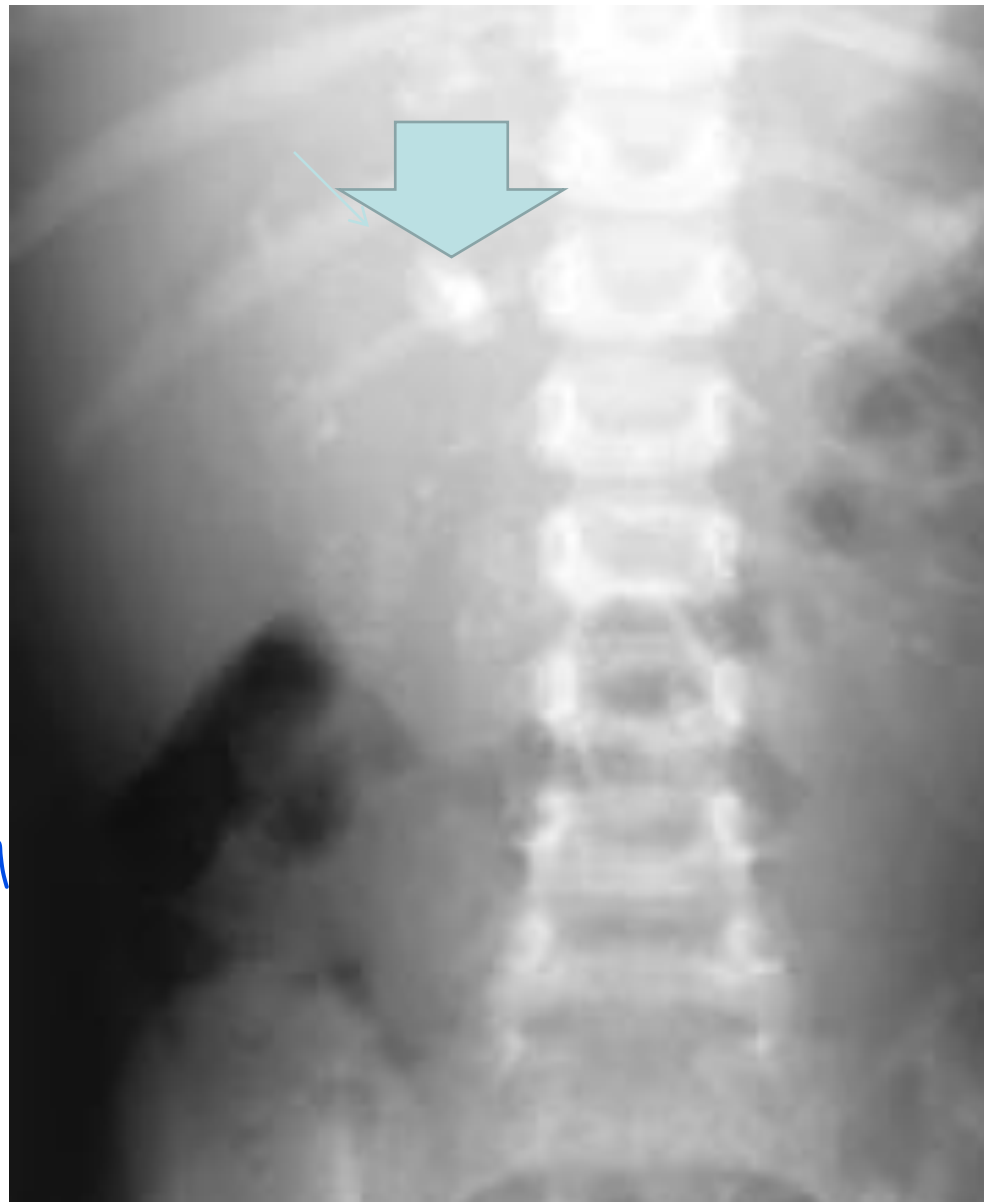
3. Костни аномалии

1 Кор стена

2 Кор аорта 5 Инсти

3 Аневризъм 6 Метаст

4 Ту-Невробластом



Обзорна графия на корема с предно-задна посока на лъч

1. Легнало,
проксимален илеус,
не се вижда
хидроаерично ниво
2. Изправено
3. Легнал странично

Я МР >



Границите не са резки и да
Образът е характерен за:



интензитет от мезен

1. **Остеом**

мелу

2. **Миелом**

3. **Ангиолипом**

4. **Хордом**

Rö

КТ на гръдна клетка. Патологичните промени на белия дроб представляват:

КТ



- 1. Дилатация на бронхи**
2. Кавитации в паренхима
3. Дилатация на кръвоносни съдове

Една от тарзалните кости е променена поради асептична некроза. Коя е тя?

Къолер - AVN

аваскуларна некроза

1. Os cuboideum

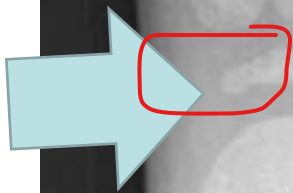
2. **Os naviculare**

3. Os cunieforme

костта

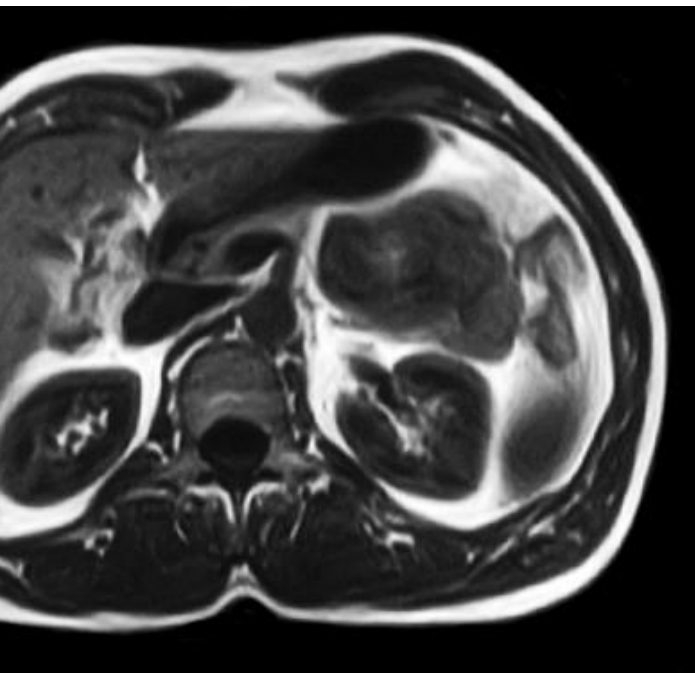
супинатор.

Rö



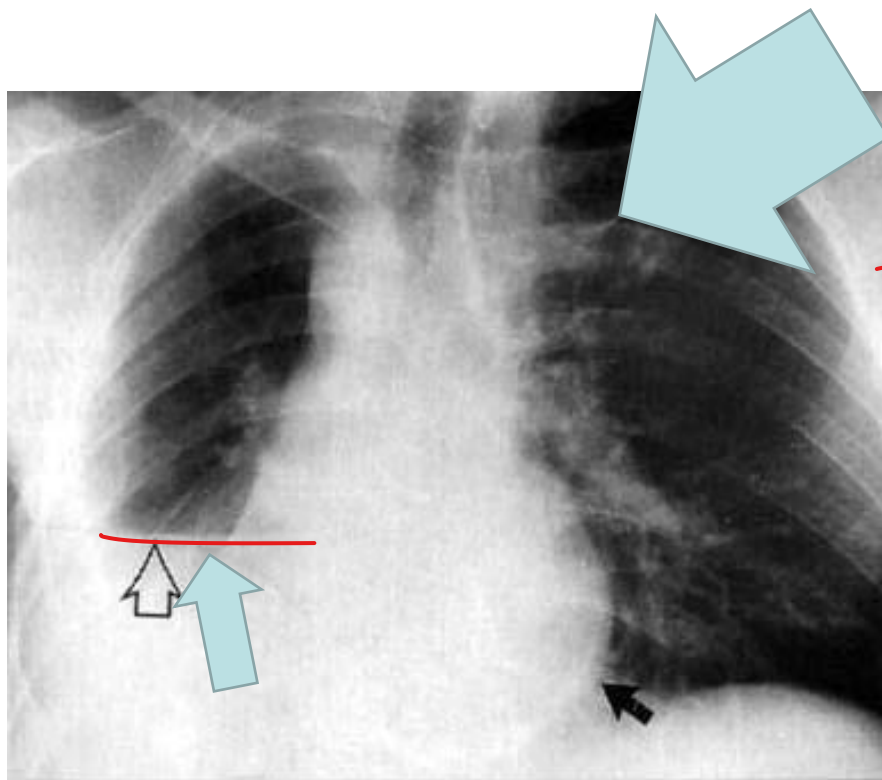
Този транзверзален срез е получен чрез:

ЯМР



1. Компютърна томография
2. Компютърна томография с контрастно усилване
3. Конвенционална томография
4. **Магнитно резонансна томография > черни кости**

Посоченото с бялата стрелка засенчване в дясната основа се дължи на:



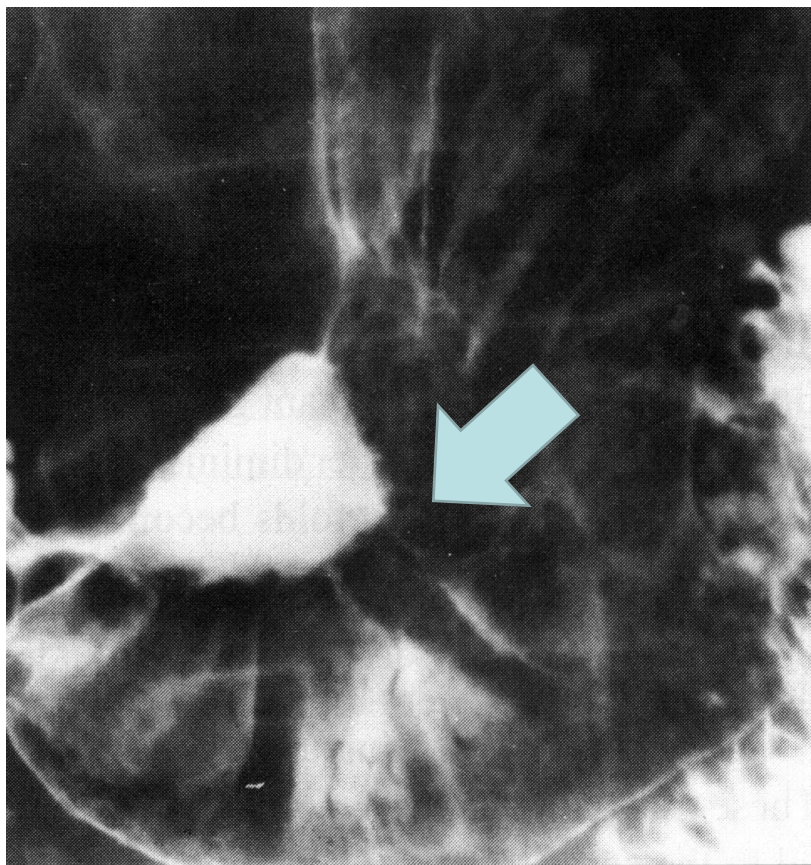
1. Диафрагмална херния
2. **Хидропневмоторакс**
3. Хидроторакс

Rö

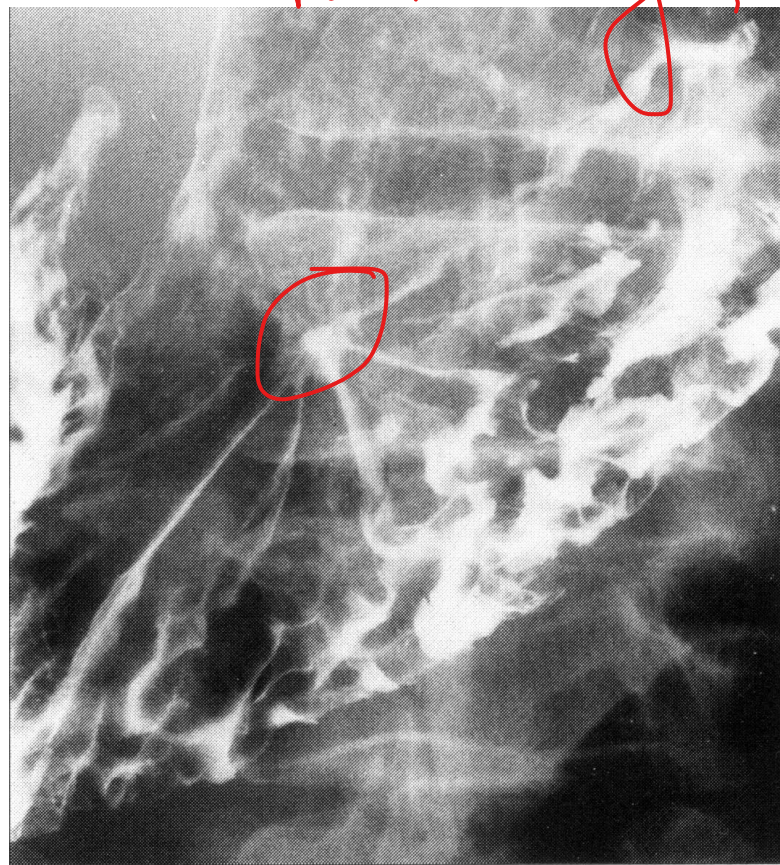
Малигнената язва е под номер:

Rö с КМ

Язвена НМН
Конверсия

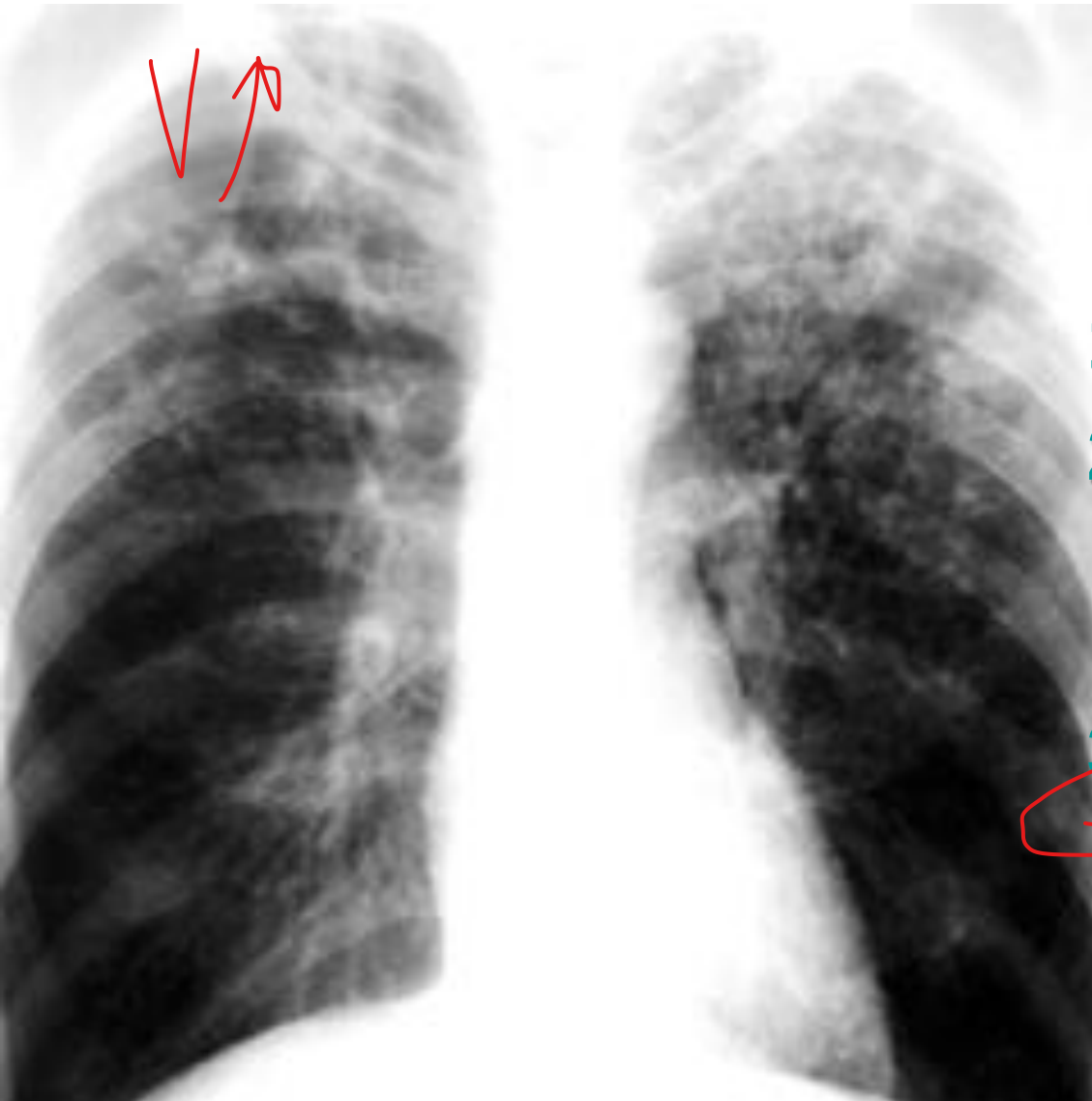


1-има прекъсване на
лигавичните гънки



2

Двустранното ангажиране на върховете на белия дроб най-вероятно се дължи на



и това

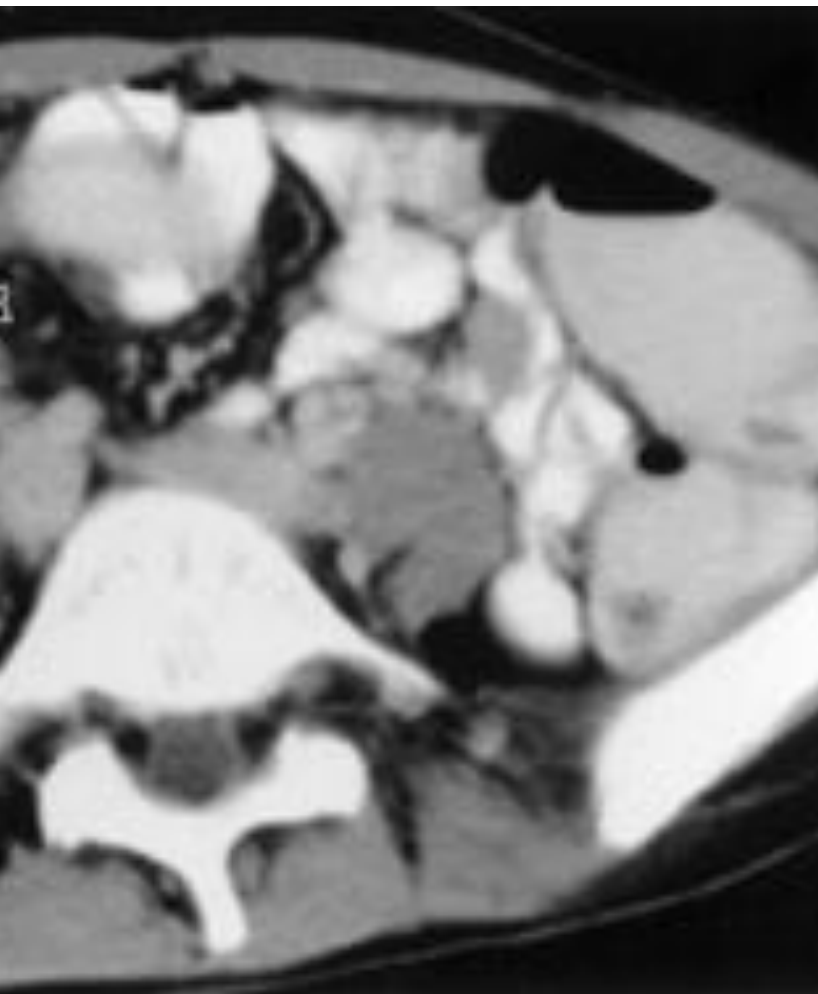
може, иЗ

1. Карциноматоза
2. Венозен застой при митрална стеноза
3. **Туберкулоза**

V / Q

P.O.
12

8. Болестта на Крон е усложнена с абсцес в:



1. Мезоколона
2. Бъбречната капсула

3. М. псоас

КТ

Начинът на засягане на интерфалангеалните стави е както

ри:



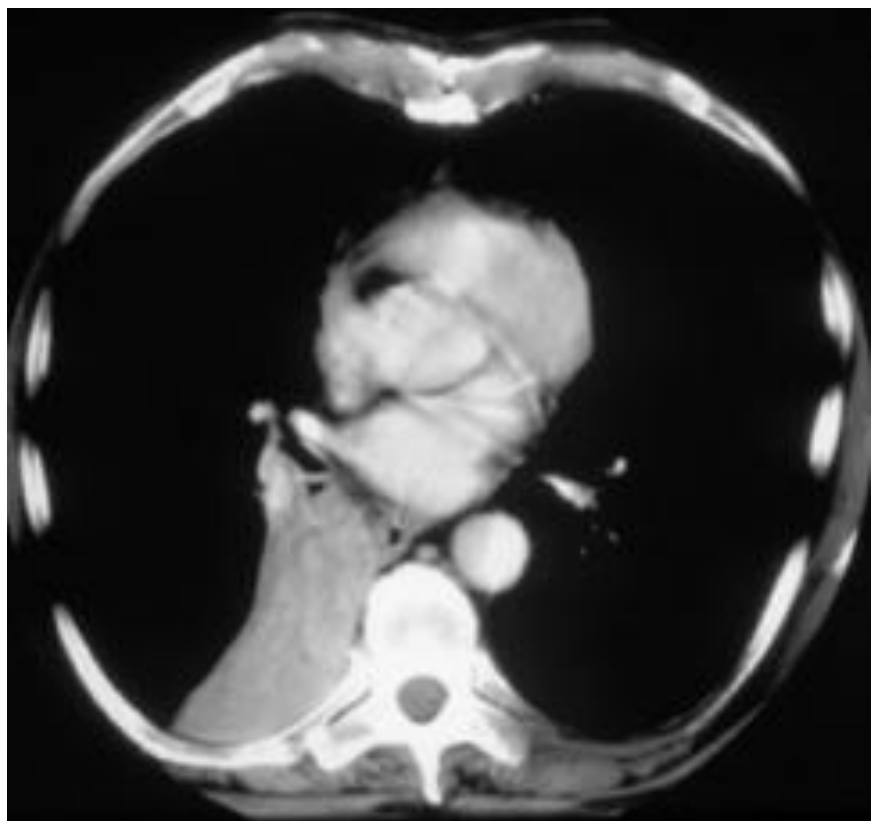
1. Остеоартрит

2. Ревматоиден артрит

3. Подагра

деформиращ
артроз
Rö

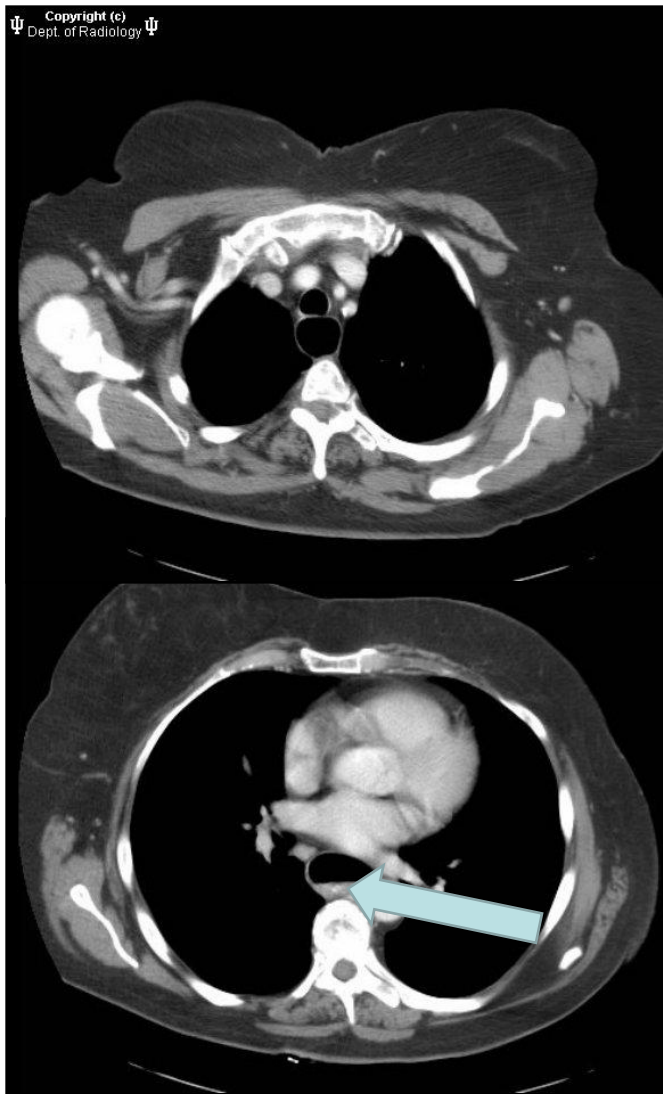
На кой дял е ателектазата:



1. Долен десен
2. Горен десен
3. Среден десен

V5

Абнормалността е в:



КА

1. аортата

2. хранопровода

3. трахеята

СТПА и кту
при
непознание
на корозивни
в-ва

В какъв стадий е субдуралният хематом?

КТ

1. Остър
2. Подостър
3. Хроничен,
защото е
хиподенсен

НДМС
кръв



На микционната цистография

патологичен е:



1. **Левият уретер**
2. **Десният уретер**
3. **Пикочният мехур**

диаметрант е
мочеотсрещу

Микционна
цистография

Начинът на засягане на интерфалангеалните стави
е както при:



1. Остеоартрит

2. Ревматоиден
артрит- хроничен

3. Остеомиелит

Рiö

Рс:

Костната лезия се дължи на:



1. Костна киста

2. **Енхондром-**

доброкачествен тумор
засягащ кортекса,
килийчеста структура.

3. Метастаза

+ калцификации

Може ли находката от КТ да се определи като адултна форма на поликистоза?



КТ

1. Да

2. Не- трябва да
е двустранно

това е АД
заболяване,
затова още
СА, на нив на

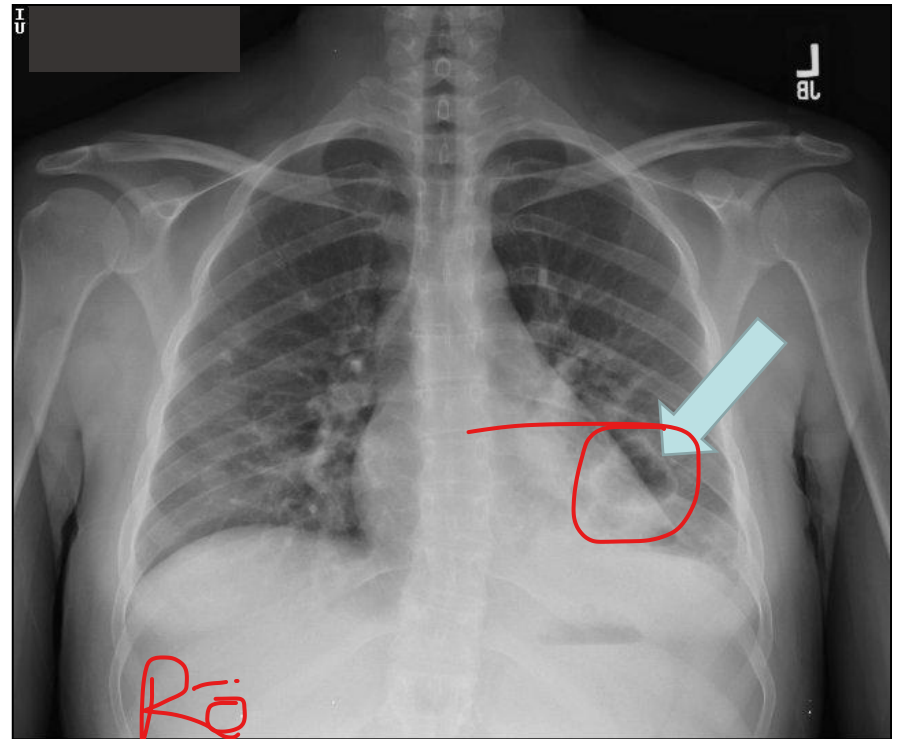
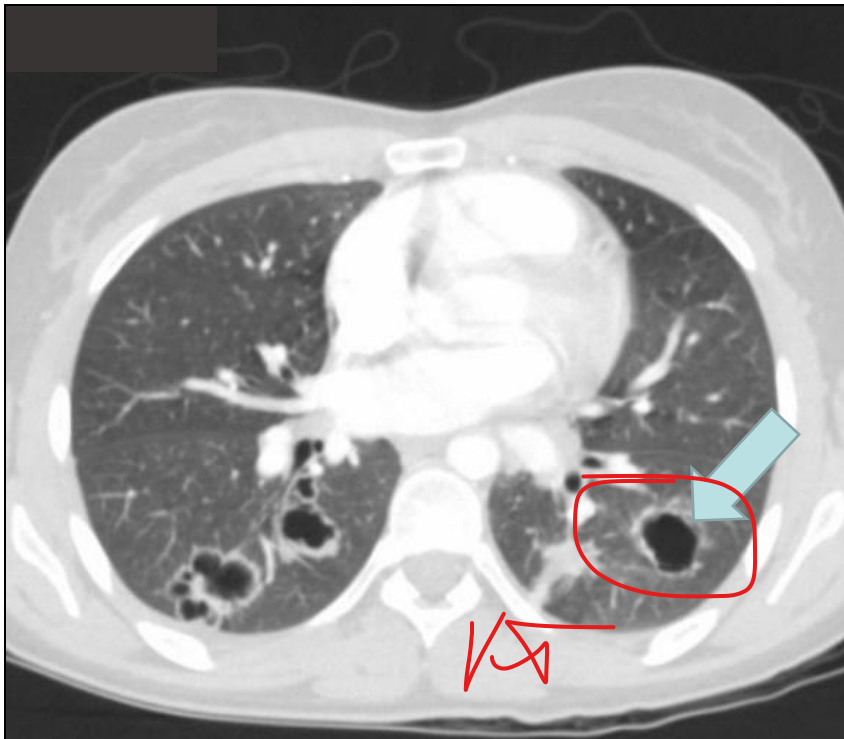
Огнищните лезии в белия дроб при тази
млада жена са:

1. Кавитации

2. Възпалителни инфилтрати

3. Паренхимни формации

след JTBK, Абулс



В костите на таза се наблюдава:

1. Петниста остеопороза

2. Петниста остеосклероза

3. Петниста остеолиза

↓ костна
матрица

DEXA



Рi

Rö

Това е болест на:

1. Клатцкин
2. Крукенберг
3. Кьолер 2
4. Курваозие
5. Кинбьок
6. Кароли
7. Капоши

AVN



1. Трикуспидалната клапа се разполага

:

- 1. Между ляво предсърдие и лява камера**
- 2. Между дясно предсърдие и дясна камера**
- 3. Между лява камера и аорта**
- 4. Между дясна камера и белодробна артерия**

2. Торакалните прешлени се разполагат:

- 1. Каудално от лумбалните**
- 2. Краниално от цервикалните**
- 3. Каудално от цервикалните**

3. Белодробната тромбоемболия представлява:

1. Тромбоза на белодробните вени

2. Тромбоза на белодробните артерии

3. Тромбоза на бронхите

4. Епифизите са елементи на:

1. Дългите кости

2. Плоските кости

3. Носните кости

5. Тимусната жлеза се разполага:

1. Ретросакрално

2. Ретрокавално

3. Ретроаурикуларно

4. Ретростернално

5. Ретробулбарно

1. Малкият кръг на кръвообращението включва следните последователно разположени анатомични структури:

- 1. Дясно предсърдие -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**
- 2. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**
- 3. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> лява камера**
- 4. Дясна камера -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**

2. Кистите (на различни органи) на компютъртомографския образ най-често са:

1. Хиподенсни

2. Хиперденсни

3. Изоденсни

3. Белодробната тромбоемболия представлява:

1. Тромбоза на белодробните вени

2. Тромбоза на белодробните артерии

3. Тромбоза на бронхите

4. Епифизите са елементи на:

1. Дългите кости

2. Плоските кости

3. Носните кости

5. Бъбречните калици съдържат нормално:

1. Вторична урина

2. Венозна кръв

3. Първична урина

4. Артериална кръв

1. Малкият кръг на кръвообращението включва следните последователно разположени анатомични структури:

- 1. Дясно предсърдие -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**
- 2. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**
- 3. Дясна камера -> аорта -> пулмонални вени -> лява камера**
- 4. Дясна камера -> пулмонална артерия -> пулмонални вени -> ляво предсърдие**

2. Кистите (на различни органи) на компютъртомографския образ най-често са:

1. Хиподенсни

2. Хиперденсни

3. Изоденсни

3. Белодробната тромбоемболия представлява:

1. Тромбоза на белодробните вени

2. Тромбоза на белодробните артерии

3. Тромбоза на бронхите

4. Епифизите са елементи на:

1. Дългите кости

2. Плоските кости

3. Носните кости

5. Бъбречните калици съдържат нормално:

1. Вторична урина

2. Венозна кръв

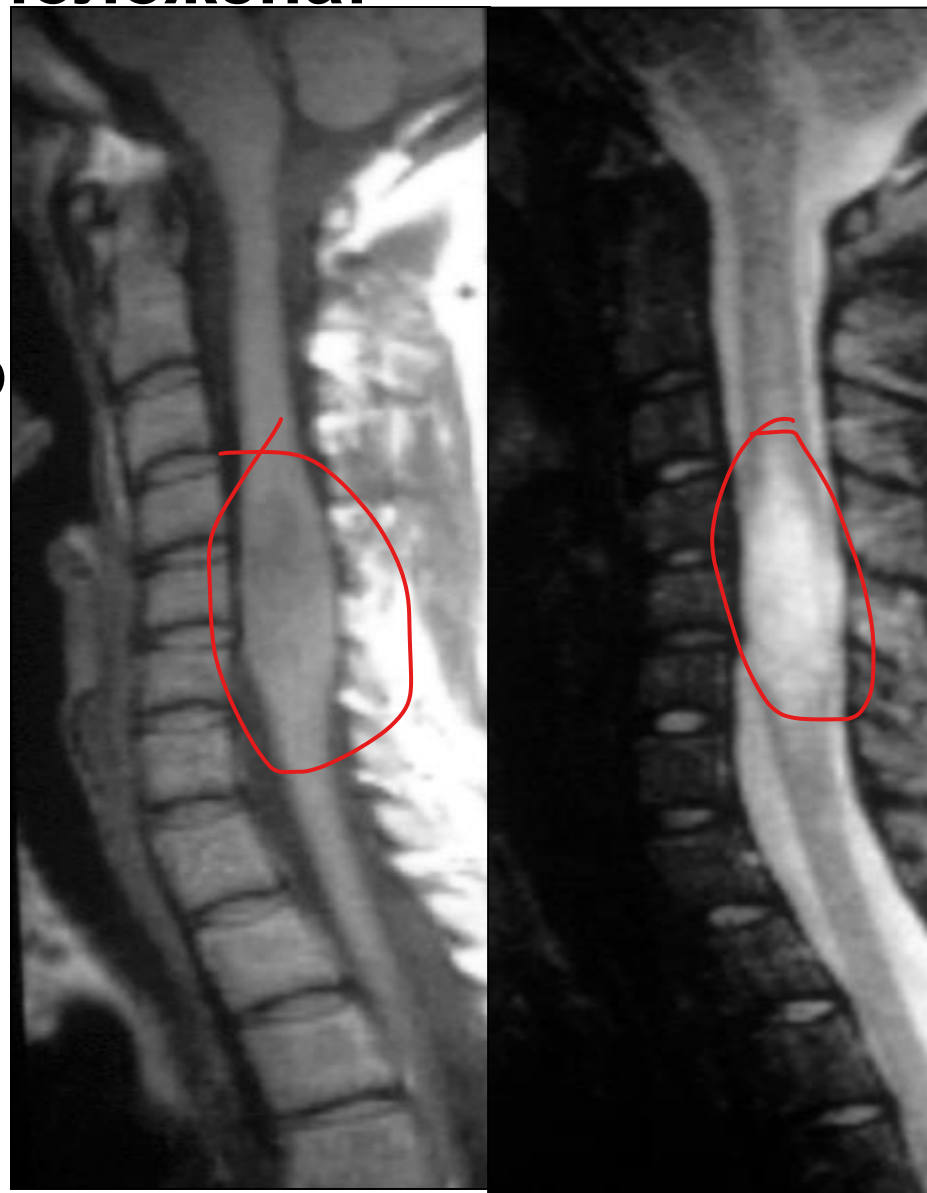
3. Първична урина

4. Артериална кръв

Патологичната лезия в гръбначномозъчния канал е разположена:

1. **Интрамедуларно**
2. Екстрамедуларно интрадурално
3. Екстрадурално

ЯМР

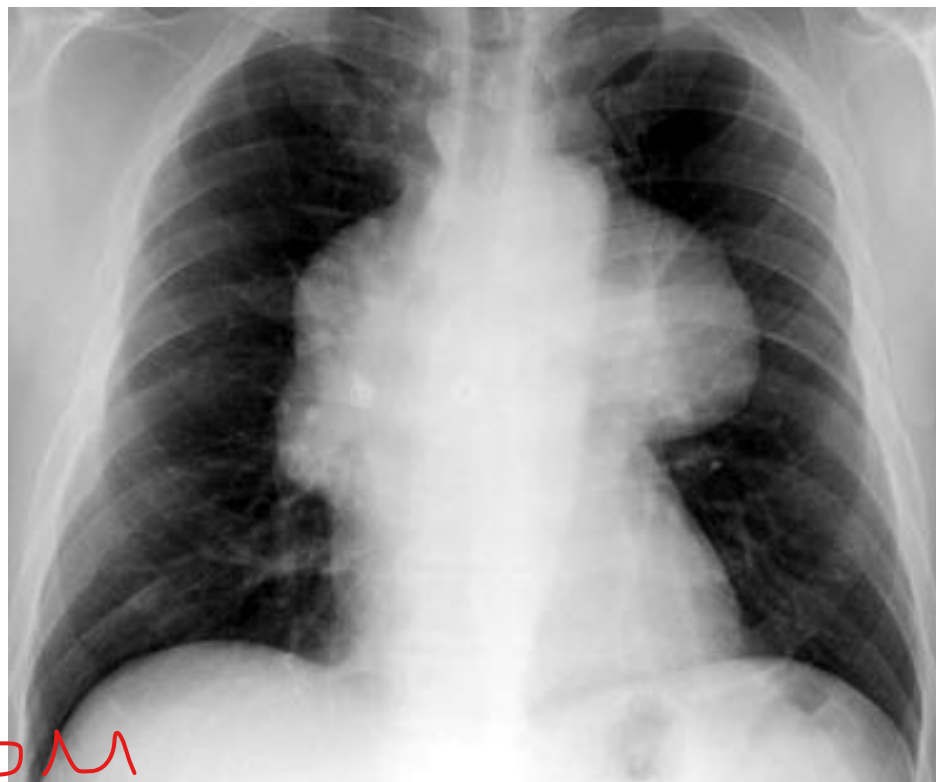


**Рентгеновата находка се причинява от една
от следните причини:**

Rö

1. Съдова
медиастинална
2. Туморна екстра-
медиастинална

3. Туморна
медиастинална



тимома, лимфом

ефективна тумор

Субдуралният хематом е:

КСА



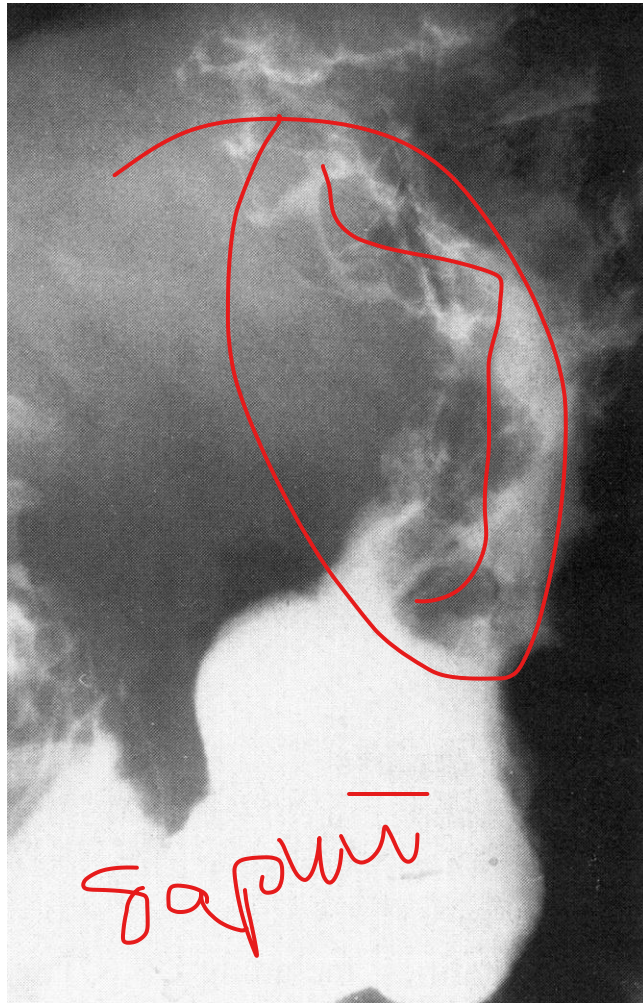
1. **Остър-** Hb и Fe^{2+}
хиперденсен

2. Подостър

3. Хроничен

Rö с КОНТРАСТ

Промените в стомаха са:



1. Добавни сенки
2. Дилатация на кух орган
3. Дефекти в изпълването

позитивен
контраст

Патологичната сянка е с характерна картина

Rö

на:

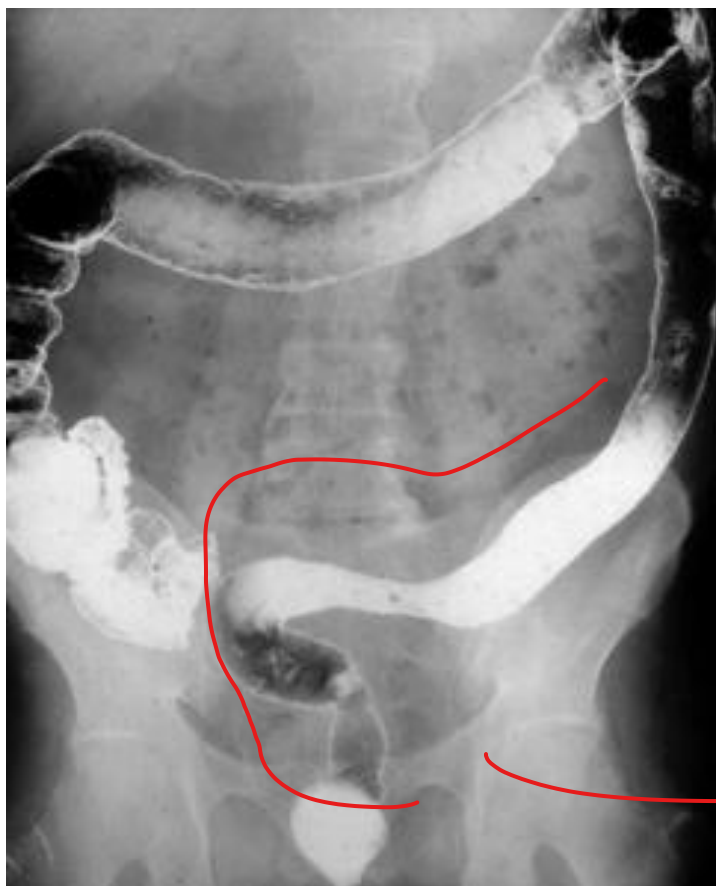
1. Пневмония
2. Капсулиран плеврален излив

3. Ателектаза на горния дял

воланс на БД
перетхим →
консигура
↑ мътност



Посочете верния отговор:



3. **Улцерозен**
КОЛИТ- оловна
тръба

2. **Болест на Крон**

3. **Илеус**

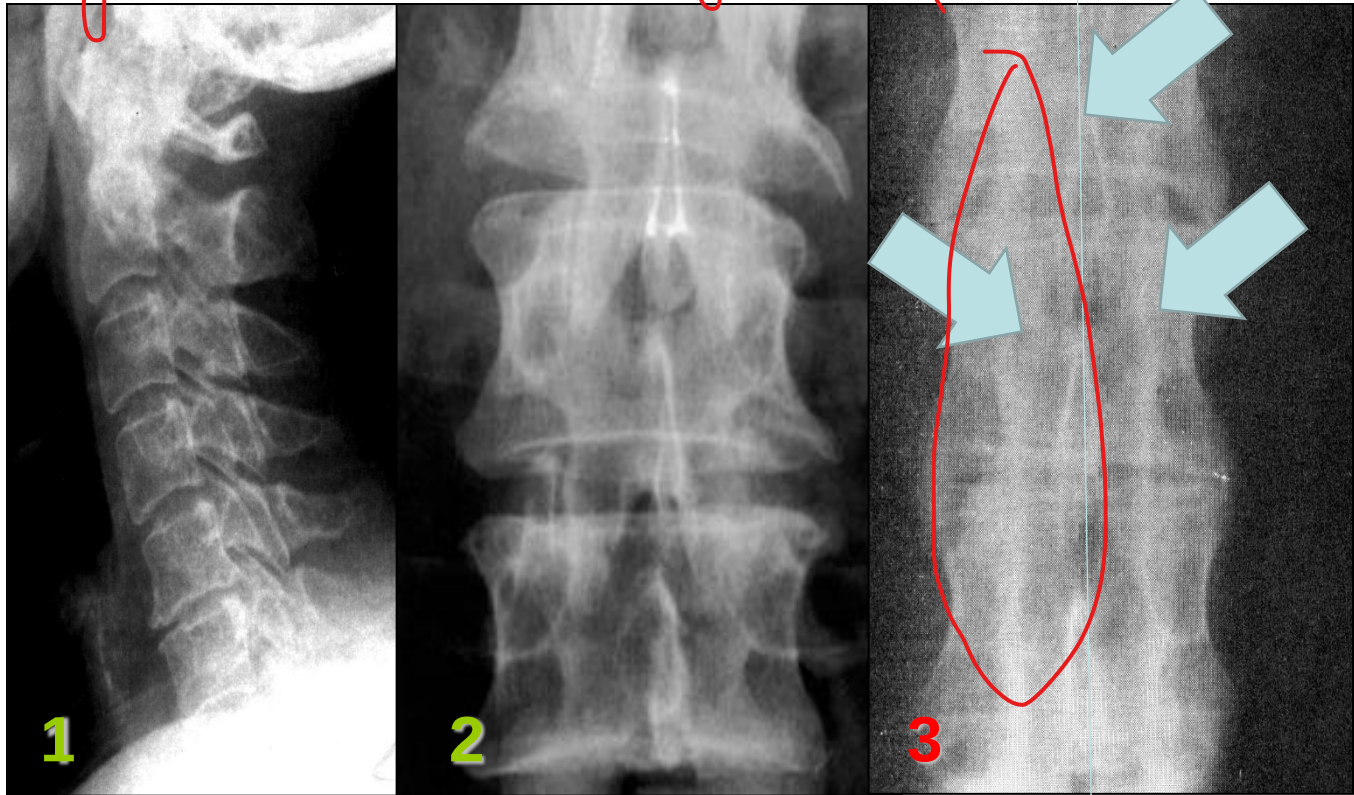
→ ректосигмоидна
област

Rö. с/м

На коя от графите на гръбначен стълб има болест на Бехтерев

анкилозиран спондилит
1.9 → фиброза → сакруликум и гръбна

Rö



**1. Малкият кръг на кръвообращението
включва следните последователно
разположени анатомични структури:**

- 1. Дясно предсърдие -> пулмонална
артерия -> ляво предсърдие**
- 2. Дясна камера -> аорта -> ляво
предсърдие**
- 3. Дясна камера -> аорта -> лява камера**
- 4. Дясна камера -> пулмонална артерия
-> ляво предсърдие**

2. Кистите (на различни органи) на компютъртомографския образ най-често са:

1. Хиподенсни

2. Хиперденсни

3. Изоденсни

3. Белодробната тромбоемболия представлява:

1. Тромбоза на белодробните вени

2. Тромбоза на белодробните артерии

3. Тромбоза на бронхите

4. Дилатирани чревни бримки се срещат при:

Механ-обструкция → проксит
от
H99

1. Илеус

2. Малигнен асцит

3. Тромбоза на порталната вена

4. Болест на Крон



5. Бъбречните калици съдържат нормално:

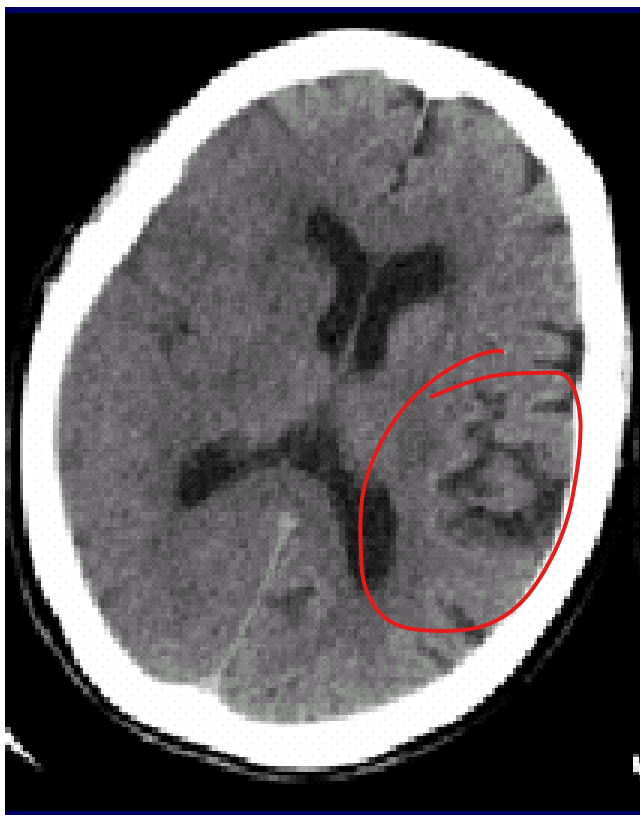
1. Вторична урина

2. Венозна кръв

3. Първична урина

4. Артериална кръв

2. Ишемичният инсулт в остър стадий е разположен в:



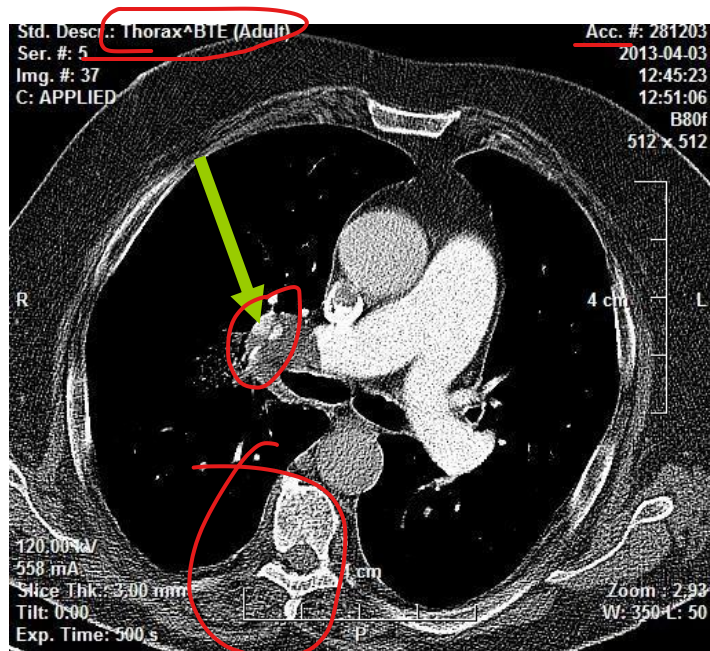
1-Вдясно

2-Вляво

1/5

Стадиите на исхемията са: 1. Свръхакутен –до 6 час, 2. Акутен – 6-12 ч, 3. Субакутен над 12 ч и т.н.

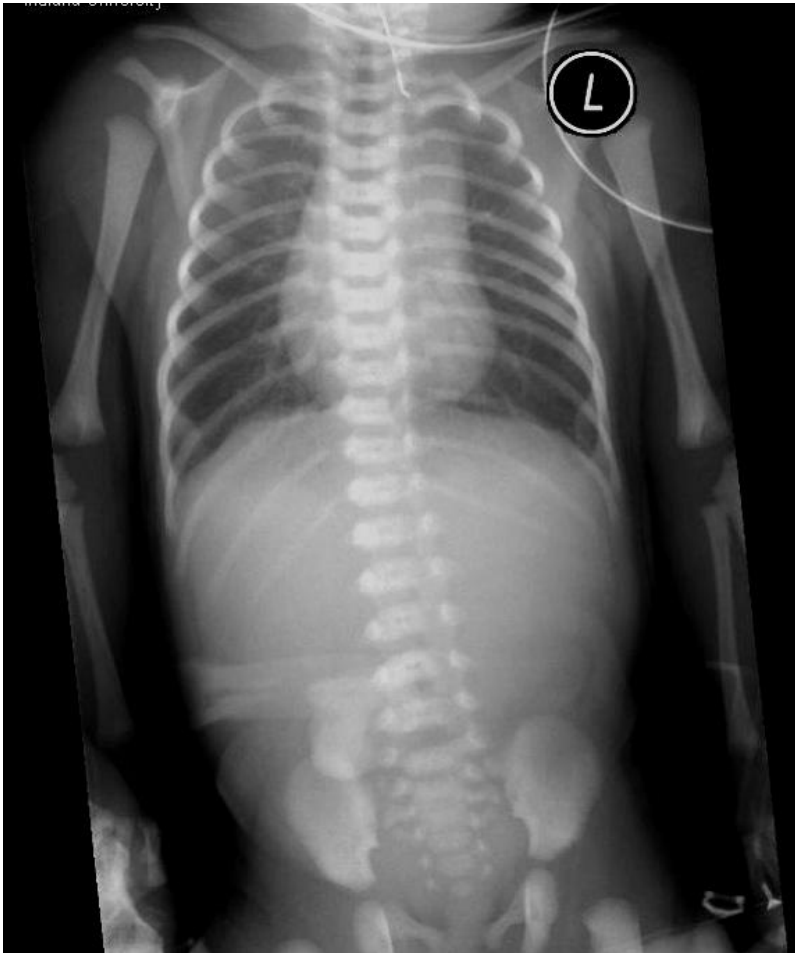
4. Патологичният процес, посочен със стрелка е:



VJ

1. Белодробна тромбоемболия
2. Карцином в десния хилус
3. Чуждо тяло в бронха

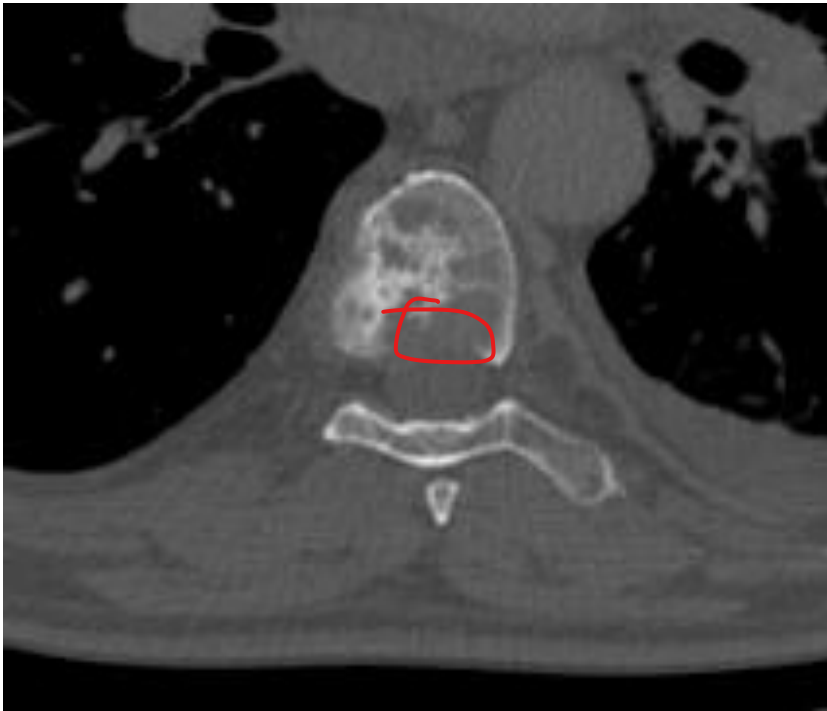
6. Рентгенографията на корема на новородено е:



1. Абнормна по причина на белия дроб и сърцето
2. Абнормна по причина на корема
3. Абнормна по причина на костите

Rö

8. Метастазата в прешлен от бронхогенен карцином е:



1. **Остеосклеротична**

2. **Остеолитична**

3. **Смесена** *хипог.*

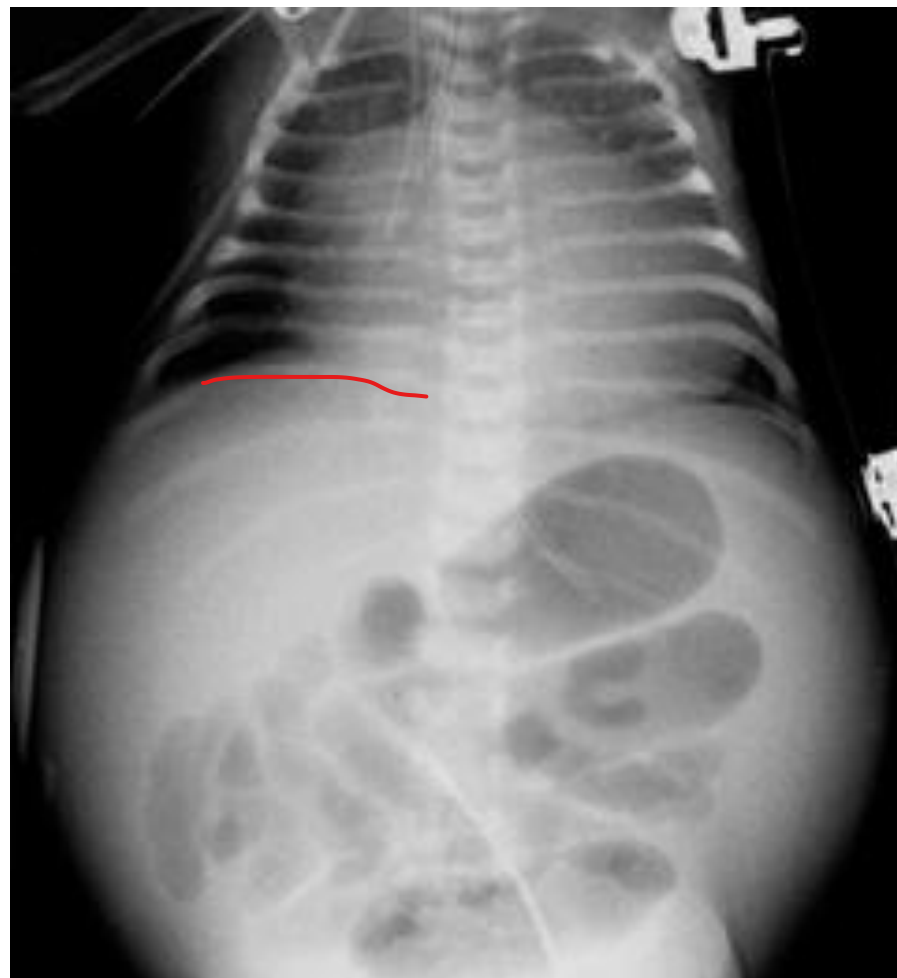
зона

КТ

1. Находката от абдоминалната рентгенография на новородено се дължи на:

1. Инвагинация
2. **Асцит**
3. Илеус
4. Перфорация

RO на новор



2. Прицелна графия на дясна белодробна основа. Засенчването в КДС най-вероятно се дължи на:

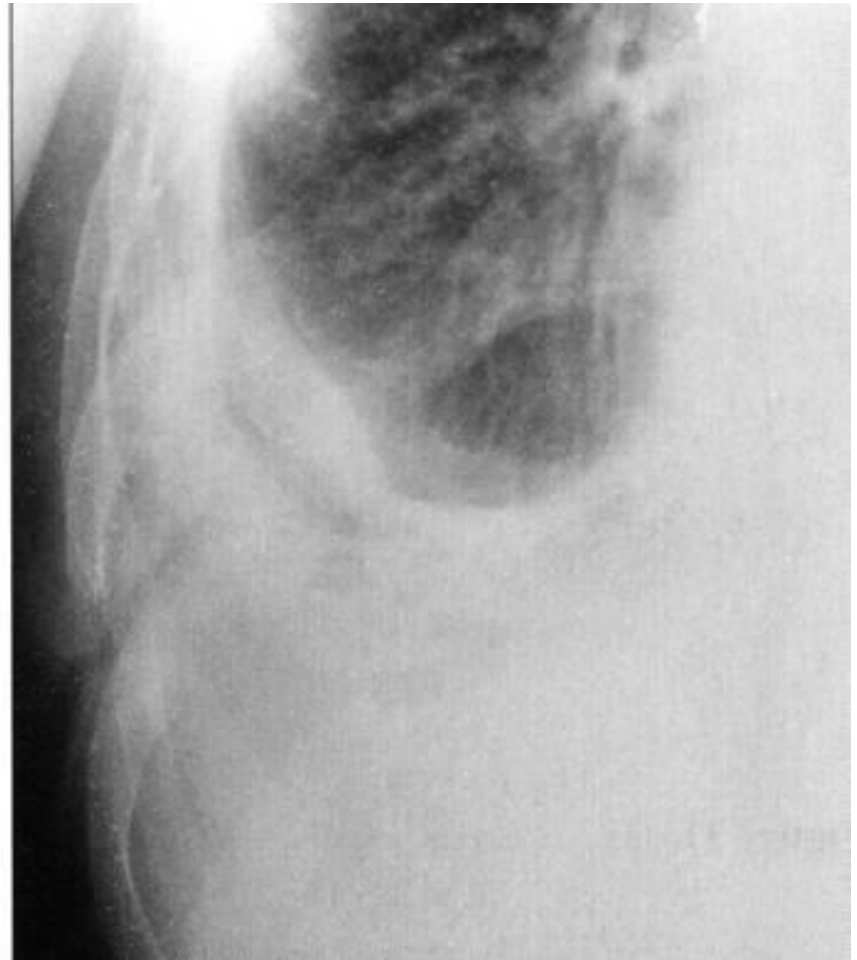
Рѐ

1. Срастване

2. Емпием

3. Серозен излив

ПНМ

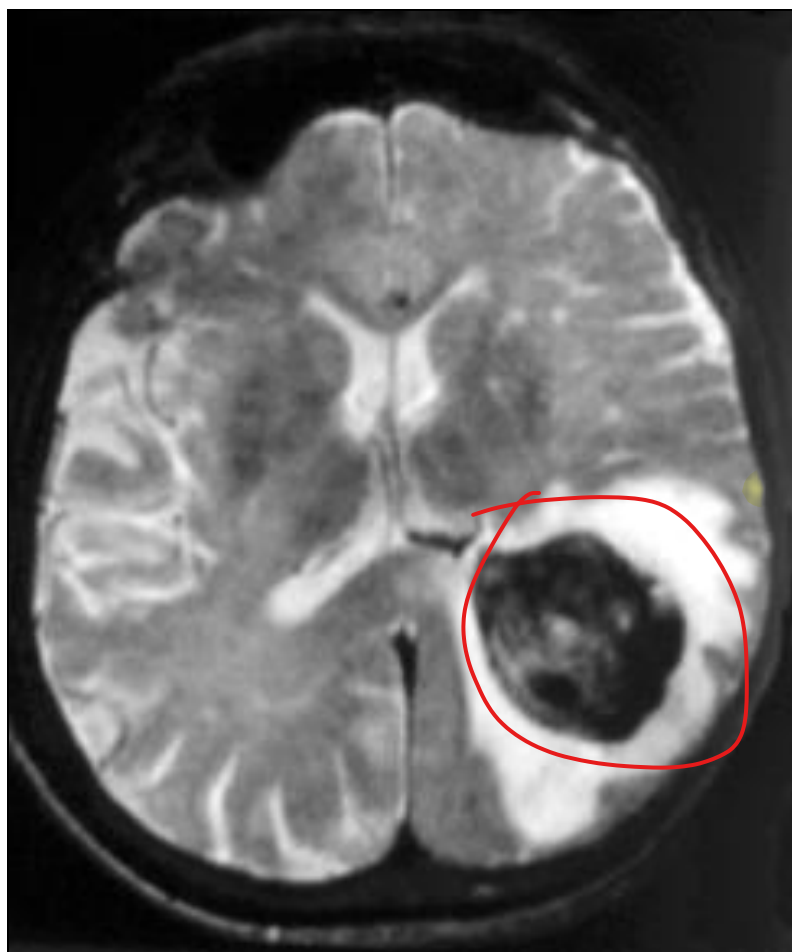


3. Патологичната лезия в гръбначномозъчния канал е разположена:

1. Интрамедуларно
2. Екстрамедуларно
интрадурално
3. Екстрадурално



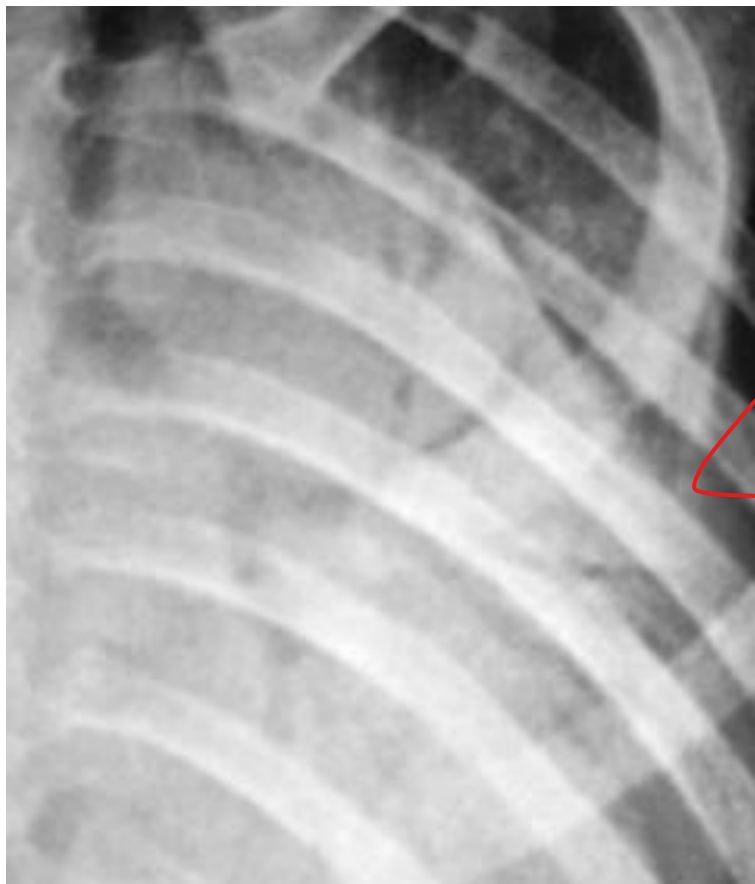
4. Патологичната лезия е разположена:



1. Инфратенториално
2. Екстрааксиално
3. **Интравентрикуларно**
4. Интрааксиално

gmp

5. Слабите сенки се дължат на:



1. Разпад в инфилтрат

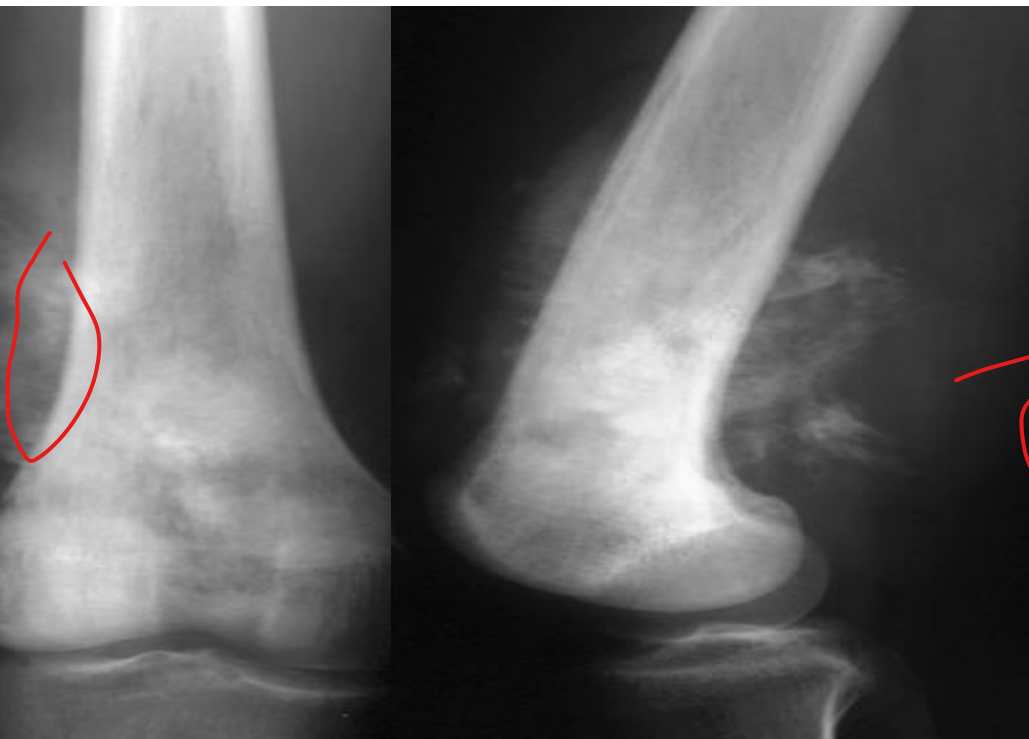
2. Интерстициален едем

3. Въздушна бронхограма

пневмония

Rö

6. Представената спикULOобразна периостална реакция е типична за:



1. Остеомиелит
2. Травматичен
периостит
3. Малигнен тумор на
костта- четина
4. Метастаза

при форма периостит
He ce бивага

Rö.